

TEMA 7.12 • PSIQUIATRÍA GENERAL

Trastornos Ansiosos I: Generalidades y Crisis de Pánico

PERFIL EUNACOM 1.03.1.003

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Los **Trastornos Ansiosos** comprenden un grupo de patologías psiquiátricas frecuentes caracterizadas por un estado patológico de angustia, miedo o ansiedad que genera un impacto significativo en la calidad de vida y funcionalidad del paciente.

Clasificación de los Trastornos Ansiosos

Es fundamental distinguir entre las distintas entidades, ya que aunque comparten la base de la ansiedad, su presentación y desencadenantes varían:

TABLA 7.12.1: TRASTORNO VS CARACTERÍSTICA DISTINTIVA

TRASTORNO	CARACTERÍSTICA DISTINTIVA
Trastorno de Pánico	Crisis de pánico recurrentes e inesperadas (sin causa evidente).
Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG)	Ansiedad y preocupación constante ("apellido" generalizada).
Agorafobia	Miedo a situaciones donde escapar sea difícil o no haya ayuda disponible.
Fobia Social	Ansiedad intensa ante situaciones de exposición social.
Fobias Simples	Miedo específico a objetos o situaciones (ej. arañas, alturas).
Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC)	Obsesiones (ideas) que generan angustia y compulsiones (actos) para calmarla.
Estrés Postraumático (TEPT)	Síntomas tras un evento traumático (evolución > 1 mes).
Estrés Agudo	Similar al TEPT pero con duración menor a 1 mes desde el evento.
Trastorno Adaptativo	Respuesta desproporcionada a un estresor identificable (puede ser ansioso, anímico o mixto).

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: La ansiedad es una respuesta adaptativa normal ante el peligro. Se vuelve patológica cuando es desproporcionada al estímulo, persistente en el tiempo o aparece de forma espontánea, involucrando una desregulación de los sistemas de neurotransmisión (principalmente serotonina, noradrenalina y GABA).

Clínica General y Diagnóstico

- El diagnóstico de todos estos trastornos es **estrictamente clínico**. Los síntomas nucleares son:
- Angustia/Ansiedad/Miedo:** Sensación subjetiva de malestar e inquietud.
- Conductas de Evitación:** El paciente evita situaciones que asocia con la aparición de los síntomas (ej. no salir solo, no ir a lugares concurridos).
- Síntomas Físicos:** Palpitaciones, sudoración, temblor, disnea.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Antes de diagnosticar un trastorno psiquiátrico, se debe descartar: - **Causas Orgánicas:** Hipertiroidismo, feocromocitoma, arritmias. - **Consumo de Sustancias:** Intoxicación por cocaína, anfetaminas o cafeína.

La Crisis de Pánico (El Síntoma)

Es crucial entender que la **crisis de pánico** es un síntoma y no una enfermedad por sí sola. Puede ocurrir en el contexto de una **Depresión**, un trastorno de pánico o incluso en personas sanas bajo estrés extremo.

Características de la Crisis:

- **Inicio Súbito:** Alcanza su máxima intensidad en menos de 10 minutos.
- **Duración Limitada:** Suele durar minutos y ceder espontáneamente.
- **Cortejo Vegetativo:** Palpitaciones, opresión torácica, vértigo, sudoración.
- **Síntomas Disociativos:** Despersonalización (sentirse fuera de uno mismo).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Tratamiento de la Crisis Aguda: Se utilizan **Benzodiacepinas (BZD)** de acción rápida por vía **sublingual** o endovenosa para una absorción inmediata. - Ejemplo: **Lorazepam 2 mg sublingual**. - Otros: Alprazolam, Midazolam.

Trastorno de Pánico (La Enfermedad)

También llamado **Trastorno de Angustia**. Se define por la presencia de crisis de pánico **recidivantes** que no tienen una causa explicada o gatillante evidente.

Elementos Clave:

- **Ansiedad Anticipatoria:** El paciente vive con miedo a que le dé una nueva crisis ("miedo al miedo").
- **Interpretación Catastrófica:** Durante la crisis, el paciente siente que va a morir, volverse loco o sufrir un infarto.
- **Asociación con Agorafobia:** Es común que el paciente desarrolle miedo a estar en lugares públicos. Si están presentes ambos, el diagnóstico principal es Trastorno de Pánico con Agorafobia.

Diagnóstico Diferencial y Exámenes

Para cumplir con el criterio de "exclusión de causa orgánica", en el estudio inicial de un paciente con síntomas ansiosos se deben solicitar al menos:

- **TSH:** Para descartar **Hipertiroidismo** (presentación clínica idéntica).
- **Electrocardiograma (ECG):** Para descartar arritmias como la **Fibrilación Auricular** paroxística o TPSV.
- **Glicemia:** Para descartar episodios de hipoglicemia (que cursan con síntomas adrenérgicos).

Tratamiento Farmacológico General

El manejo de los trastornos ansiosos crónicos (Pánico, TAG, TOC, TEPT) se basa en dos pilares:

1. Tratamiento de Mantenimiento (Preventivo)

Se utilizan **Antidepresivos**, específicamente los **ISRS (Inhibidores Selectivos de la Recaptura de Serotonina)**. Son los encargados de evitar que las crisis ocurran a futuro. - **Regla de oro:** Iniciar con dosis muy bajas e ir subiendo lentamente. - **Ejemplo:** Fluoxetina 10 mg/día por 1-2 semanas, luego subir a la dosis habitual de 20 mg/día. - **Razón:** Al inicio del tratamiento, los antidepresivos pueden aumentar transitoriamente la ansiedad.

2. Tratamiento Sintomático (Rescate)

Se utilizan las **Benzodiacepinas (BZD)**. - Se usan al inicio del tratamiento (mientras el antidepresivo hace efecto, que demora 2-4 semanas) o durante las crisis. - Deben ser retiradas gradualmente hasta llegar a dosis cero. - Ejemplo: Alprazolam 0.5 mg cada 8-12 horas.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, si preguntan por el tratamiento de la **crisis**, la respuesta es **Benzodiacepinas**. Si preguntan por el tratamiento del **trastorno (la enfermedad)**, la respuesta es **Antidepresivos (ISRS)**.

Diferencias en el Manejo según el Trastorno

- **Trastornos Crónicos/Severos (Pánico, TAG, TOC, TEPT):** Requieren farmacoterapia (ISRS + BZD) y psicoterapia.
- **Fobia Simple, Estrés Agudo y Trastorno Adaptativo:** Habitualmente son cuadros más agudos o puntuales que se benefician principalmente de **psicoterapia** y manejo de estresores, reservando los fármacos para casos específicos o síntomas muy limitantes.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca dejar Benzodiacepinas de forma indefinida debido al riesgo de dependencia, tolerancia y deterioro cognitivo en adultos mayores. El tratamiento definitivo siempre es el ISRS.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Mujer de 32 años llega a urgencias muy angustiada, con palpitaciones, sensación de ahogo, mareos y sensación de que "se va a morir". Los síntomas iniciaron hace 10 minutos y están en el pico. Refiere que ya le ha ocurrido 3 veces este mes sin causa aparente. ¿Cuál es el manejo inmediato de la crisis?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Trastornos Ansiosos I: Generalidades y Crisis de Pánico. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La crisis de pánico es un síntoma (no una enfermedad): inicio súbito, múltiples síntomas, pico en <10 minutos; manejo: lorazepam 2 mg sublingual.
- En la crisis de pánico siempre descartar causa orgánica: ECG (FA paroxística, TSVP), TSH (hipertiroidismo) y glicemia (hipoglicemia).
- El trastorno de pánico (angustia) se trata con ISRS a largo plazo; las benzodiacepinas son solo para las crisis.
- Los ISRS en trastornos ansiosos se inician a dosis más bajas que en depresión para evitar exacerbación de la ansiedad al inicio.
- La agorafobia es el miedo a no recibir ayuda (no solo a espacios abiertos); si coexiste con trastorno de angustia, prima el diagnóstico de trastorno de angustia con agorafobia.
- La fobia social (ansiedad social) es el miedo al escrutinio público; se diferencia del TPE (trastorno de personalidad evitativo) en que la fobia social mantiene vida social normal fuera de esas situaciones.
- Todos los trastornos ansiosos crónicos (excepto fobia simple y estrés agudo) se tratan con ISRS + benzodiacepinas sintomáticas.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRASTORNOS ANSIOSOS I: GENERALIDADES Y CRISIS DE PÁNICO)**PREGUNTA 1**

Mujer de 32 años llega a urgencias muy angustiada, con palpitaciones, sensación de ahogo, mareos y sensación de que "se va a morir". Los síntomas iniciaron hace 10 minutos y están en el pico. Refiere que ya le ha ocurrido 3 veces este mes sin causa aparente. ¿Cuál es el manejo inmediato de la crisis?

- A)** Fluoxetina 20 mg oral
- B)** Lorazepam 2 mg sublingual
- C)** Haloperidol 5 mg IM por agitación psicomotora
- D)** Propranolol 40 mg oral
- E)** Observación y no medicamentar

PREGUNTA 2

Al mismo caso anterior: una vez controlada la crisis, ¿cuál es el tratamiento de fondo más adecuado para el trastorno de pánico?

- A)** Alprazolam 0.5 mg cada 8 horas de manera crónica
- B)** Antidepresivo ISRS (fluoxetina, sertralina) a dosis baja inicial, escalando gradualmente
- C)** Psicoterapia sin fármacos, ya que el pánico no requiere medicación
- D)** IMAOs (fenelzina) como primera línea
- E)** Litio por el riesgo de viraje bipolar

PREGUNTA 3

Hombre de 28 años refiere que cada vez que debe presentar trabajos en el trabajo siente pánico, se le va la voz y queda paralizado. Fuera de esas situaciones tiene muchos amigos, pareja estable y vida social activa. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Trastorno de personalidad evitativo
- B)** Fobia social (trastorno de ansiedad social)
- C)** Trastorno de angustia generalizada
- D)** Trastorno de pánico con agorafobia
- E)** Fobia simple a las presentaciones

RESUMEN: TRASTORNOS ANSIOSOS I: GENERALIDADES Y CRISIS DE PÁNICO

Los trastornos ansiosos incluyen el trastorno de pánico (o angustia), el trastorno de ansiedad generalizada, la agorafobia, la fobia social, las fobias simples, el TOC, el trastorno de estrés postraumático (TEPT), el estrés agudo y el trastorno adaptativo. Todos se caracterizan por angustia, miedo o ansiedad como síntoma central. La mayoría presenta conductas evitativas. El diagnóstico es clínico y se requiere descartar causas orgánicas. El tratamiento general combina antidepresivos ISRS (tratamiento de fondo) con benzodiacepinas como tratamiento sintomático de las crisis. Los ISRS deben iniciarse a dosis muy baja en trastornos ansiosos para no desencadenar síntomas ansiosos al inicio. La crisis de pánico es un síntoma inespecífico que puede aparecer en varios trastornos ansiosos y también en otras patologías psiquiátricas. La crisis de pánico se caracteriza por inicio súbito (segundos a minutos), pico de síntomas en menos de 10 minutos y presencia de múltiples síntomas simultáneos: palpitaciones, disnea, opresión torácica, vértigo, sudoración y/o despersonalización. Siempre incluye miedo o ansiedad intensa. Su manejo agudo es con benzodiacepinas de acción rápida por vía sublingual o endovenosa (lorazepam 2 mg sublingual es el más usado; alprazolam, midazolam son alternativas). Es fundamental descartar causas orgánicas: ECG para arritmias paroxísticas (fibrilación auricular, TSVP) y TSH para hipertiroidismo. La glicemia descarta hipoglicemia que puede simular una crisis de angustia. El trastorno de pánico (angustia) se define por crisis de pánico recidivantes sin gatillante claro identificable, asociadas a ansiedad anticipatoria (miedo a que venga la crisis) y miedo a las consecuencias (infarto, muerte). Se diferencia de la fobia simple en que en el pánico las crisis ocurren sin gatillante específico; en la fobia hay una causa identificable. El tratamiento del trastorno de pánico es antidepresivo ISRS (no benzodiacepinas) para el control a largo plazo.